

Model *dual control*

Pobudzenie seksualne to nie jeden przycisk — to dwa systemy: pobudzający (SES) i hamujący (SIS). U każdego inaczej ustawione. Klucz do zrozumienia PPU.

CZAS: 25 min Psychoedukacja seksuologiczna

ŹRÓDŁO: Bancroft & Janssen (2000); Janssen i wsp. (2002); Carpenter i wsp. (2008)

JAK UŻYWAĆ

Model dual control (Bancroft i Janssen, Indiana University) — fundamentalna teoria seksuologii klasycznej. Pokazuje, że pobudzenie seksualne jest **wynikiem przewagi** dwóch równoczesnych procesów: *SES* (sexual excitation system — pobudzający) i *SIS* (sexual inhibition system — hamujący). Każdy z nich ma *wrodzony poziom* u danej osoby. PPU często wynika z **niezbalansowanej kombinacji**: wysokie SES + niskie SIS. Karta pomaga Ci rozpoznać własny profil.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Klasyczne modele PPU traktowały pobudzenie jako binarne (jest / nie ma). Bancroft i Janssen (2000) pokazali w badaniu $n=2\ 100$, że jest to **wynik wektorowy** dwóch niezależnych systemów. Praktyczne znaczenie: 1) *nie wszyscy* z wysokim libido mają problem (jeśli SIS równoważy SES) i *nie wszyscy* z PPU mają wysokie libido (czasem niskie SIS — łatwo dają się pobudzać byle czym), 2) interwencje muszą celować w *konkretny system*: u jednych w obniżenie SES (mindfulness, redukcja ekspozycji), u innych w wzmocnienie SIS (planowanie konsekwencji, warunkowanie awersyjne). Carpenter i wsp. (2008): osoby z PPU mają średnio **SES o 1 odchylenie standardowe wyższe** i **SIS o 0,7 odchylenia niższe** niż populacja ogólna.

01 📋 Dwa systemy — SES i SIS

SES — SYSTEM POBUDZAJĄCY

co cię pobudza, jak silnie

Aktywuje się na bodźce: wizualne, dotyk, zapach, fantazja, kontekst, nowość. **Wysoki SES**: pobudzenie szybkie, łatwe, na wiele różnych bodźców. **Niski SES**: pobudzenie powolne, wymaga konkretnego kontekstu.

Mechanizm neurobiologiczny: aktywacja dopaminergicznego układu nagrody, jądro półleżące, podwzgórze.

SIS — SYSTEM HAMUJĄCY

co cię wyhamowuje

Aktywuje się na sygnały zagrożenia / kosztów: ryzyko nakrycia, lęk o wyniki, niski nastrój, brak prywatności, świadomość konsekwencji. **Wysoki SIS**: łatwo wycofuje pobudzenie. **Niski SIS**: pobudzenie trwa nawet w obecności sygnałów hamujących.

Mechanizm: kora przedczołowa, ciało migdałowe, serotonina.

Pobudzenie = SES – SIS. Tak długo, jak $SES > SIS$, jesteś pobudzony/-a. Gdy SIS wygrywa — pobudzenie ustępuje. Cel: *nie eliminacja* SES, tylko **zbalansowanie** obu systemów.

02 ☺ Cztery profile — gdzie jesteś

A · WYSOKIE SES + WYSOKIE SIS

Silne libido, ale silne hamowanie. Pobudzenie zwykle kontrolowane. PPU rzadko. Czasem dysfunkcje seksualne (zbyt wysokie hamowanie).

B · WYSOKIE SES + NISKIE SIS

Klasyczny profil PPU. Łatwo pobudza się, trudno hamuje. „Pociąg odjeżdża, ja nie umiem go zatrzymać”.

C · NISKIE SES + WYSOKIE SIS

Niskie libido, łatwo hamowane. Ryzyko dysfunkcji seksualnych, nie PPU. Czasem partner/-ka osoby PPU.

D · NISKIE SES + NISKIE SIS

Niskie libido „tł”, ale słaba kontrola w razie pobudzenia. Rzadki profil — czasem występuje przy współwystępujących zaburzeniach.

03 Twój profil — autorefleksja

MÓJ SES — CO/JAK SILNIE MNIE POBUDZA

— rodzaje bodźców, czas reakcji, częstotliwość

MÓJ PROFIL

— A, B, C czy D z sec. 02

MÓJ SIS — CO MNIE HAMUJE, JAK SKUTECZNIE

— co działa, co nie

CO Z TEGO WYNIKA DLA MOJEJ TERAPII

— gdzie szukać interwencji

04 Co działa na każdy system

OBNIŻENIE SES

- Redukcja ekspozycji na bodźce (urlop od ekranów, blockery)
- Uważna obserwacja bez reagowania
- Higiena snu, redukcja stresu (kortyzol nasila SES)
- Ruch fizyczny — rozładowuje napięcie
- Ostrożnie: ewentualne leki (SSRI obniżają libido, ale to nie cel)

WZMOCNIENIE SIS

- Świadome przypominanie konsekwencji (lista wartości, koszt)
- Środowiskowe blokady (commitment devices, hands-off)
- Trening hamowania impulsów (CBT)
- Praca z dysregulacją emocji (DBT — bo emocje obniżają SIS)
- Plan „jeśli-to” (implementation intentions, Gollwitzer)

Klucz: Carpenter i wsp. (2008, n=2 067) w badaniu populacyjnym wykazali, że **SES i SIS są w dużej mierze wrodzone** — heritabilność szacowana na 40-50%. To znaczy: *nie zawiniłeś sobie* wysokim SES ani niskim SIS. To biologia. **Ale** oba systemy są też *modyfikowalne* przez doświadczenie, kontekst i interwencje. Cel terapii nie jest „być normalnym”, tylko *nauczyć się żyć z własnym profilem* w sposób zgodny z wartościami. Pacjent z wysokim SES + niskim SIS będzie potrzebował zewnętrznych struktur (blockery, commitment devices) — co nie znaczy słabej woli, tylko racjonalne dopasowanie strategii do biologii.